

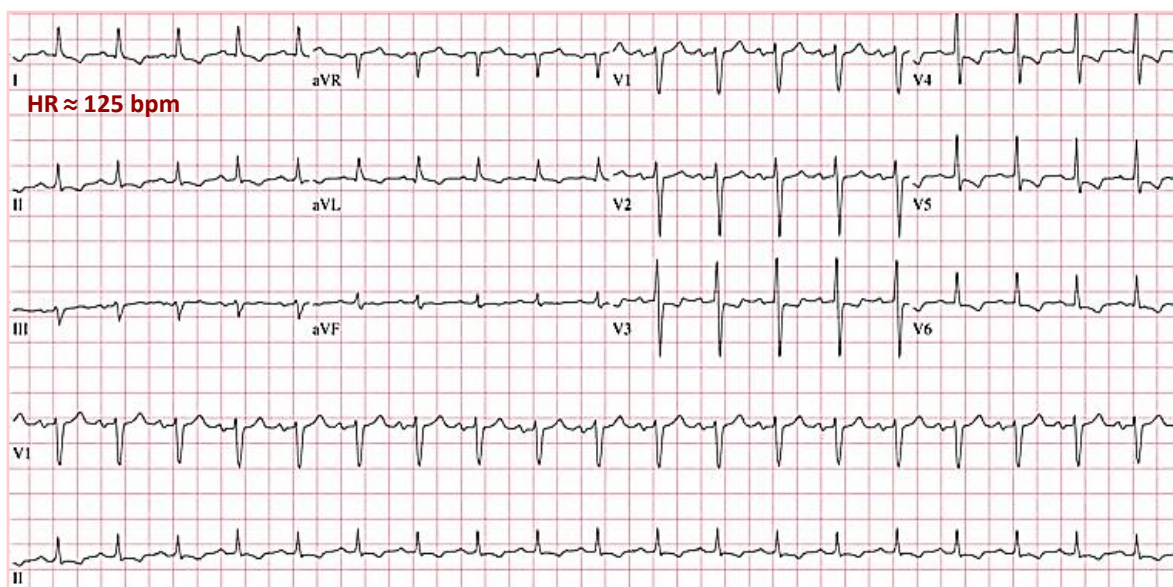
TAXYAPPYΘMIEΣ

Φλεβοκομβική ταχυκαρδία (Sinus Tachycardia)

Χαρακτηρίζεται από ρυθμό $HR > 100-180$ σφύξεις/λεπτό. Το έπαρμα P και το διάστημα PR είναι φυσιολογικά. Το έπαρμα P πρέπει να είναι θετικό στις απαγωγές I και aVF.

Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρωτοπαθής αρρυθμία, αλλά μάλλον ως απάντηση του οργανισμού σε ένα νοσογόνο ερέθισμα ή κατάσταση. Έτσι, μπορεί να οφείλεται σε:

- i. Φυσιολογικά ερεθίσματα (άλγος, κόπωση, stress, φόβος, κύηση, κ.λπ.).
- ii. Φαρμακευτικά αίτια (καφεΐνη, συμπαθομιμητικά, βρογχοδιασταλτικά, αντιισταμινικά).
- iii. Παθολογικές αιτίες (πυρετός, σοβαρή αναιμία, υποξία, υποογκαιμία, τραύμα, σήψη, υπερθυρεοειδισμός, πνευμονική εμβολή, μυοκαρδιακή ισχαιμία [βλ. εικονιζόμενο ΗΚΓ], νεόπλασμα, υπογλυκαιμία, υπερκαλιαιμία, υπομαγνησισαιμία, φαιοχρωμοκύττωμα, κ.ά.).



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη θεραπευτική παρέμβαση για την φλεβοκομβική ταχυκαρδία.
2. Σε ιδιαίτερες όμως περιπτώσεις, στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης πρέπει να είναι η ανεύρεση και αντιμετώπιση της υποκείμενης παθοφυσιολογικής διαδικασίας. Έτσι, η **αντιμετώπιση της υποκείμενης νοσογόνου καταστάσεως** πιθανώς να απαιτεί την ενδοφλέβια χορήγηση υγρών για την υποογκαιμία, τη χορήγηση οξυγόνου (O_2) για την υποξία, τη χορήγηση αναλγητικών για τον πόνο ή αντιπυρετικών για τον πυρετό, την διερεύνηση και αντιμετώπιση του υπερθυρεοειδισμού, της αναιμίας, της σήψης, κ.λπ.
3. Στις περιπτώσεις εκείνες που η διόρθωση της υποκείμενης νόσου απαιτεί χρόνο και τα συμπτώματα της φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας είναι μη ανεκτά (π.χ. υπερθυρεοειδισμός, αναιμία), σκεφτόμαστε την πιθανότητα χορήγησης βραδυκαρδιακών φαρμάκων. Ειδικά, στην περίπτωση υποκείμενου υπερθυρεοειδισμού, συνιστάται η χρήση β-αναστολέων, όπως **Προπρανολόλη** (tab. **Inderal** 40 mg, 1x1 ή 1x2, αναλόγως του καρδιακού ρυθμού) ή **Ατενολόλη** (tab. **Tenormin** 25 mg ή 50 mg, 1x1), μέχρι την επίτευξη ευθυρεοειδισμού.
4. Η χορήγηση της **Ιβαμπραδίνης** (**Procoralan**, αναστολέας των διαύλων If) σε δοσολογία 5 mg ή 7,5 mg, δύο φορές ημερησίως, σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν αντένδειξη ή δυσανεξία στους β-αποκλειστές (π.χ. άσθμα, μυασθένεια), έχει καλά αποτελέσματα στη ρύθμιση της φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας, χωρίς τις παρενέργειες των β-αναστολέων.
5. Αποφασίζουμε την παραπομπή στο νοσοκομείο, εφόσον η ταχυκαρδία είναι σοβαρή και εμμένουσα κι εφόσον το αίτιό της απαιτεί νοσηλεία για διερεύνηση και αντιμετώπιση.